FICHE RÉFLEXE 1/4 · PERTINENCE DES ACTES D'IMAGERIE

Lombalgie commune

Radiographie du rachis lombaire

L'inutilité de la radiographie standard pour la lombalgie commune a été démontrée dans de multiples situations cliniques.[1]

Arbre décisionnel

Signe d'urgence ?
- Sciatique hyperalgique rebelle aux opiacés
- Sciatique paralysante (déficit moteur < 3 MRC ou progressif)
- Syndrome de la queue de cheval

OUI → **Imagerie possible** en urgence

Suspicion de fracture ?
- Traumatisme important récent
- Corticothérapie prolongée
- Âge > 70 ans

OUI → **Imagerie possible**

Suspicion de néoplasie ?
- Âge > 50 ans
- Altération de l'état général, perte de poids inexpliquée
- Antécédent tumoral

OUI → **Imagerie possible**

Suspicion d'infection ?
- Fièvre
- Douleur au repos, d'aggravation progressive, à recrudescence nocturne
- Infection urinaire · immunodépression · drogues IV

OUI → **Imagerie possible**

Sous traitement ?
- Absence d'évolution favorable sous traitement symptomatique
- Élimination formelle d'une lombalgie spécifique avant manipulation ou infiltration

OUI → **Imagerie possible**

NON à toutes les questions → **PAS DE RADIOGRAPHIE** du rachis lombaire

RÉFLEXE ACCUEIL / MANIPULATEUR

Toute demande « lombalgie » sans mention d'un critère de l'arbre est montrée au radiologue avant réalisation.

PHRASE TYPE AU PRESCRIPTEUR

« Radiographie non réalisée : lombalgie commune sans signe d'alerte, situation où la radiographie n'est pas recommandée (HAS / SFR). À reconsidérer en cas d'échec du traitement ou d'apparition d'un signe d'alerte. »

Contenu clinique repris des fiches pertinence FNMR (recommandations HAS / SFR). Le réflexe accueil et la phrase type sont des propositions d'organisation, pas des recommandations officielles. Ne remplace pas le jugement clinique. Situations hors fiche : ADERIM (SFR).

1. FNMR – Pertinence en imagerie médicale : https://fnmr.fr/pertinence-en-imagerie-medicale/

FICHE RÉFLEXE 2/4 · PERTINENCE DES ACTES D'IMAGERIE

Crâne, sinus, massif facial

Radiographie standard

La radiographie du crâne, des sinus et du massif facial n'est pas indiquée, sauf exception. Si une imagerie est nécessaire : TDM ou IRM.[1]

Radio du crâne

Pas d'indication en règle générale.
Si une imagerie est nécessaire : **TDM ou IRM**.[1]

Selon la HAS (octobre 2008), les indications restantes sont « exceptionnelles » et appelées à évoluer : en 2018, la plupart doivent être remplacées par une imagerie en coupe.[1]

Indications restantes (HAS 2008)
Maltraitance suspectée chez l'enfant
Myélome
Tumeur osseuse primitive
Recherche de métastases osseuses
Maladies osseuses métaboliques
Maladie de Paget
Ostéomalacie
Ostéomyélite

Radio des sinus et du massif facial

Pas d'indication, sauf exception.
Si une imagerie est nécessaire : **TDM ou IRM**.[1]

Une seule indication
Dépistage d'un corps étranger intra-orbitaire : incidence de profil, complétée si nécessaire par une incidence de face.[1]

Arbre décisionnel

Corps étranger intra-orbitaire à dépister ?
- Radio des orbites

OUI → **Profil** ± face

Crâne : une des 8 indications restantes ?
- Maltraitance de l'enfant, myélome, tumeur osseuse primitive, métastases
- Maladie osseuse métabolique, Paget, ostéomalacie, ostéomyélite

OUI → **Radio possible** imagerie en coupe souvent préférable

Autre situation → **PAS DE RADIOGRAPHIE** · si imagerie nécessaire : TDM ou IRM

RÉFLEXE ACCUEIL / MANIPULATEUR

Toute demande de radio du crâne, des sinus ou du massif facial est soumise au radiologue.

PHRASE TYPE AU PRESCRIPTEUR

« La radiographie du crâne / des sinus n'est pas indiquée dans ce contexte (HAS / SFR). Si une imagerie est nécessaire, un scanner ou une IRM est l'examen adapté. »

Contenu clinique repris des fiches pertinence FNMR (recommandations HAS / SFR). Le réflexe accueil et la phrase type sont des propositions d'organisation, pas des recommandations officielles. Ne remplace pas le jugement clinique. Situations hors fiche : ADERIM (SFR).

1. FNMR – Pertinence en imagerie médicale : https://fnmr.fr/pertinence-en-imagerie-medicale/

Thorax

Radiographie standard du thorax

De nombreux contextes cliniques ne justifient pas la radio du thorax, soit parce que l'imagerie est inutile, soit parce qu'ils nécessitent une autre technique.[1]

Non-indications de la radiographie du thorax[1]

Contexte	La radio du thorax n'est pas indiquée
Urgences	• Admission sans trouble cardio-pulmonaire aigu • Suspicion de perforation œsophagienne • Suspicion de dissection aiguë de l'aorte thoracique • Suspicion de rupture d'anévrisme de l'aorte thoracique
Réanimation	• Suivi d'un patient stable et ventilé • Suivi à distance de la position d'un matériel implanté
Pré-opératoire	• Chirurgie non cardiothoracique chez un sujet de moins de 60 ans, sans pathologie cardio-vasculaire ou avec une pathologie stable
Cardio-vasculaire (hors péri-opératoire)	• HTA • Suivi d'une insuffisance cardiaque congestive chronique ou d'une cardiomyopathie
Respiratoire non tumoral	• Infection des voies aériennes hautes • Bronchite aiguë • Bronchiolite de l'enfant (1er épisode non compliqué) • Douleur thoracique non spécifique hors urgence
Respiratoire tumoral	• Dépistage du cancer bronchique • Dépistage du mésothéliome

Hors de ces situations, l'utilité de la radiographie standard du thorax a été démontrée dans de multiples situations cliniques.[1]

Certains contextes nécessitent une autre technique : **TDM, IRM, échographie-doppler...** Le détail des rares indications restantes figure dans le rapport complet de la HAS.[1]

RÉFLEXE ACCUEIL / MANIPULATEUR

Repérer les demandes « bilan pré-op », « systématique » et « dépistage », et les soumettre au radiologue.

PHRASE TYPE AU PRESCRIPTEUR

« Radiographie du thorax non indiquée en bilan pré-opératoire systématique chez un patient de moins de 60 ans sans pathologie cardio-vasculaire (HAS / SFR). »

Contenu clinique repris des fiches pertinence FNMR (recommandations HAS / SFR). Le réflexe accueil et la phrase type sont des propositions d'organisation, pas des recommandations officielles. Ne remplace pas le jugement clinique. Situations hors fiche : ADERIM (SFR).

1. FNMR – Pertinence en imagerie médicale : https://fnmr.fr/pertinence-en-imagerie-medicale/

Abdomen sans préparation (ASP)

Adulte et enfant

L'ASP est très rarement indiqué, chez l'adulte comme chez l'enfant.[1]

Adulte : ASP très rarement indiqué.
Le plus souvent remplacé par **échographie et/ou TDM**.[1]

Enfant : ASP très rarement indiqué.
Le plus souvent : **échographie**.[1]

Indications restantes : adulte et enfant[1]

	Adulte	Enfant
Alternative	Échographie et/ou TDM, si une imagerie est justifiée	Échographie le plus souvent ; l'ASP complète parfois une échographie non contributive
Colectasie	Colite aiguë grave dans la maladie de Crohn et la RCH	Suspicion de colectasie (MICI)
Corps étranger	Surtout si acéré ou potentiellement toxique	Surtout si acéré ou potentiellement toxique
Lithiase rénale	Suivi de colique néphrétique · exploration péri-opératoire (écho et TDM : alternatives selon taille et localisation)	En cas d'échographie non contributive
Douleurs abdominales	—	Échographie non contributive · suspicion d'occlusion · suspicion de perforation
Spécifique	Recherche de stérilet non visible en échographie	Nouveau-né : suspicion d'entérocolite Masse abdominale : calcifications après échographie (inutile si une TDM est envisagée)

Hors de ces indications → **PAS D'ASP** · proposer l'échographie (± TDM chez l'adulte)

RÉFLEXE ACCUEIL / MANIPULATEUR

Toute demande d'ASP est soumise au radiologue.
Proposer l'échographie en première intention.

PHRASE TYPE AU PRESCRIPTEUR

« L'ASP est très rarement indiqué (HAS / SFR). Une échographie et/ou un scanner sont plus adaptés dans ce contexte. »

Contenu clinique repris des fiches pertinence FNMR (recommandations HAS / SFR). Le réflexe accueil et la phrase type sont des propositions d'organisation, pas des recommandations officielles. Ne remplace pas le jugement clinique. Situations hors fiche : ADERIM (SFR).

1. FNMR – Pertinence en imagerie médicale : https://fnmr.fr/pertinence-en-imagerie-medicale/